16/02/2026

L’Euthanasie et la décohérence du droit

Je voudrais synthétiser l’excellente analyse du Dr Umlil sur la décohérence du Droit par rapport à l'Aide à mourir/euthanasie. Cette vidéo est à écouter de toute urgence.

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/live/z7Xm5qm8dH

1. Contexte général.

L’échange s’inscrit dans une série de discussions autour des enjeux éthiques, juridiques et médicaux liés au projet de loi français sur l’aide active à mourir.
Louis Fouché reçoit le Dr Amine Umlil, pharmacien et juriste en droit de la santé, connu pour ses analyses critiques durant la crise sanitaire.

L’objectif : comprendre pourquoi, selon le Dr Umlil, le texte législatif crée une incohérence profonde dans le droit français.

2. Le cœur de l’argument : une loi qui crée un “homicide légal”

le Dr Umlil explique que le projet de loi introduit une situation paradoxale :

L’acte de provoquer la mort d’autrui reste, en droit pénal, un homicide.

© Céleste R. — CC BY-NC-ND

Mais la loi propose d’en autoriser certains cas, sous conditions.

Pour lui, cela revient à créer un homicide autorisé, ce qui est une rupture conceptuelle majeure.

Il insiste sur le fait que le droit français repose sur des principes fondamentaux (indisponibilité du corps humain, interdiction de tuer) qui seront ici contournés.

3. Le rôle des soignants : une responsabilité déplacée

Le Dr Umlil détaille les implications pour les professionnels de santé :
Pour les médecins :

Ils seraient amenés à évaluer la “demande” du patient.

Ils devraient valider que les critères légaux sont remplis.

Ils pourraient être amenés à administrer eux-mêmes la substance létale si le patient ne peut pas le faire.

Pour les pharmaciens :

C’est un point central de son intervention :

Le pharmacien deviendrait celui qui prépare et délivre la substance destinée à provoquer la mort.

Cela crée une responsabilité morale et juridique inédite.

Il souligne que la déontologie pharmaceutique repose sur la protection de la vie, pas sur la fourniture d’un produit létal.

Il parle d’une “instrumentalisation du pharmacien”.

4. Une rupture anthropologique

Le Dr Umlil insiste sur le fait que cette loi ne concerne pas seulement des cas individuels, mais modifie la fonction même de la médecine :

La médecine passe d’un rôle de soin à un rôle de donner la mort.

Cela transforme la relation soignant–patient.

© Céleste R. — CC BY-NC-ND

Il y voit une “rupture anthropologique”, c’est-à-dire un changement profond dans la manière dont une société conçoit la vie, la mort et le soin.

5. Retour sur son parcours et sa légitimité

Au fil de l’entretien, le Dr Umlil revient sur :

Son travail au sein du centre régional de pharmacovigilance.

Ses analyses critiques durant la crise sanitaire.

Son engagement pour le consentement libre et éclairé.

Les pressions et difficultés rencontrées lorsqu’il a dénoncé certaines pratiques.

6. Les risques.

Il identifie plusieurs dangers :

Glissement progressif : une extension probable des critères d’accès à l’aide à mourir.

Pression sociale sur les personnes vulnérables (handicap, dépendance, isolement).

Conflits d’intérêts potentiels dans l’évaluation des demandes.

Fragilisation du cadre éthique de la médecine.

Il met en garde contre une “banalisation” de l’acte de donner la mort.

7. Conclusion de l’entretien

L’échange se termine sur une réflexion plus large :

Quelle société voulons-nous ?

Comment protéger les plus fragiles ?

Comment éviter que la loi ne devienne un outil de gestion sociale de la souffrance ou de la dépendance ?

Il appelle à un débat public approfondi, loin des slogans et des émotions immédiates.

© Céleste R. — CC BY-NC-ND